

Rapport de Situation de la 17^e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°139/MVE-BDBV/30/09/2026

Date du rapport : 30 septembre 2026

Date de publication : 1er octobre 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- En date du 30 septembre 2026, 76 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), dont 28 décès communautaires ont été notifiés. Ces cas provenaient des provinces de l'Ituri (43 cas), du Nord-Kivu (31 cas), du Haut-Uélé (2 cas). De plus, 8 décès ont été enregistrés dans les CTE.
- Un total de 474 nouveaux échantillons a été analysé; 76 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 16,0 % de positivité.
- Aucune nouvelle zone de santé n'a notifié de cas confirmé au cours des dernières 24 heures.

CUMUL DES CAS
8 300

CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS
4 018

LÉTALITÉ
48,4 %

PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE
842

CUMUL DES GUÉRIS
2 162

TAUX DE SUIVI DES CONTACTS
(Du Jour)
80,6 %


Provinces touchées et zones de santé touchées



7 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et
Sud Ubangi

63 Zones de santé touchées sur 167
(37,7%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Au cours des dernières 24h, 76 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE) dont 28 décès communautaires ont été enregistrés dans 3 provinces. Les provinces ayant rapporté ces cas sont l'Ituri (43 cas), du Nord-Kivu (31 cas) et du Haut-Uélé (2 cas).

De plus, 8 décès ont été enregistrés dans les CTE (6 en Ituri et 2 au Nord-Kivu), ce qui porte à 36 le nombre total des décès confirmés pour la période considérée.

Cependant, 41 patients (27 en Ituri, 7 au Nord-Kivu, 5 au Haut-Uélé et 2 à la Tshopo) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE.

Au 30 septembre 2026, la RDC cumule 8 300 cas confirmés et 4 018 décès (létalité : 48,4 %). L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie avec 75,8 % des cas confirmés cumulés rapportés et 56,6 % des nouveaux cas confirmés. En revanche, la province du Nord-Kivu présente une létalité supérieure à la moyenne nationale, soit 59,3%.

Au total, 63 zones de santé sur 167 (37,7 %), réparties dans sept provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 30 septembre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	43	6293	2 902	46,1%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	31	1601	950	59,3%	16/34 (47,1 %)
Haut-Uélé	2	346	144	41,6%	7/13 (53,8 %)
Tshopo	0	45	16	35,6%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	10	4	40,0%	3/11 (27,3%)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3%)
Total	76	8 300	4 018	48,4%	63/167 (37,7 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 30 septembre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	6293	2902	46,1%	43	11	6	17
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	202	46	22,8%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1739	571	32,8%	11	3	4	7
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	82	31	37,8%				0
Gethy	7	3	42,9%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	37	12	32,4%	2	0	0	0
Komanda	169	103	60,9%	0	0	1	1
Lita	287	145	50,5%	3	2		2
Logo	13	5	38,5%				0
Lolwa	34	9	26,5%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	32	11	34,4%	3	0	0	0
Mandima	138	75	54,3%	1	0	0	0
Mangala	357	154	43,1%	6	0	0	0
Mongbwalu	703	333	47,4%	2	2	0	2
Nia-Nia	305	167	54,8%	7	4	1	5
Nizi	781	279	35,7%	3	0	0	0
Nyankunde	129	37	28,7%				0
Rimba	12	4	33,3%				0

Rwampara	1088	366	33,6%	5	0		0
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler *	NA	493	NA				0
Nord-Kivu	1601	950	59,3%	31	17	2	19
Beni	361	239	66,2%	13	9	1	10
Biena	19	7	36,8%				0
Butembo	267	171	64,0%	4	1	0	1
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	56	19	33,9%	2	1	0	1
Katwa	566	359	63,4%	4	2	0	2
Kayna	1	0	0,0%				0
Kyondo	33	20	60,6%				0
Lubero	21	11	52,4%				0
Mabalako	36	14	38,9%	3	2	0	2
Manguredjipa	13	5	38,5%			0	0
Masereka	29	10	34,5%	0	0	1	1
Musienene	126	68	54,0%	2	1	0	1
Mutwanga	14	2	14,3%	2	0	0	0
Oicha	27	15	55,6%	1	1	0	1
Vuhovi	31	10	32,3%				0
Haut-Uélé	346	144	41,6%	2	0	0	0
Boma Mangbetu	39	17	43,6%				0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	102	44	43,1%				0
Pawa	87	39	44,8%	2	0	0	0
Rungu	2	1	50,0%				0
Wamba	112	41	36,6%				0
Tshopo	45	16	35,6%	0	0	0	0
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	5	1	20,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	24	10	41,7%				0
Mangobo	6	3	50,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	10	4	40,0%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	6	1	16,7%				0
Ganga	3	2	66,7%				0
Sud Ubangi	2	1	50,0%	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Total	8300	4018	48,4%	76	28	8	36

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.

NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 30 septembre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	29	6	35	15	6	14	0	21	14
Bas Uélé	133	5	138	13	5	120	0	18	0
Ituri	987	61	1 048	131	61	49	0	175	106
Nord-Kivu	1 232	49	1 281	136	49	775	0	185	93
Sud Ubangi	53	0	53	1	0	48	0	0	0
Tshopo	132	1	133	7	1	125	0	8	0
Total Général	2 566	122	2 688	303	122	1 131	0	407	213

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

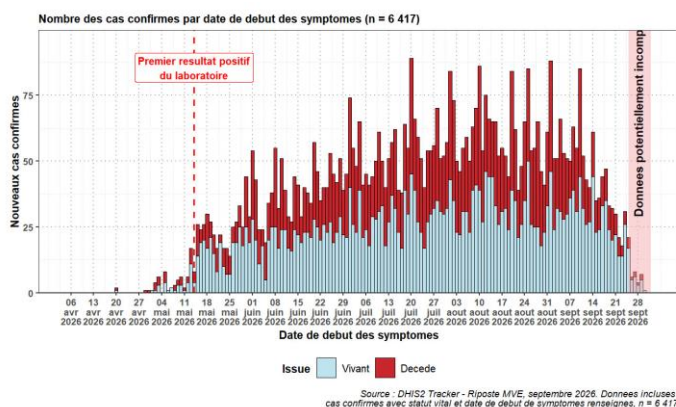
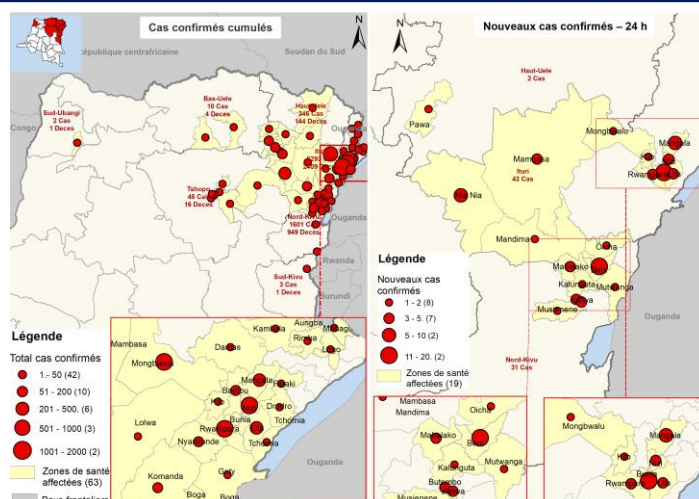


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Au terme de la journée du 30 septembre 2026, **2 688 alertes** ont été remontées, **1 556** (57,9 %) ont été vérifiées dont **425** (27,3 %) validées comme cas suspects. Parmi ceux-ci, **407** (95,8%) ont été investigués. Ainsi, 213 cas suspects ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

Parmi **32 363** contacts en cours de suivi, **26 089** contacts ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit une proportion de suivi de **80,6 %**, légèrement supérieure à celle de la veille (78,7 %) mais demeurant inférieure au seuil requis (95,0 %). Cette proportion était de 93,9 % (92/98) au Sud Ubangi), 82,1 % (11 965/14 577) en Ituri, 87,3 % (660/756) à la Tshopo, 87,0 % (161/185) au Bas Uélé, 79,1 % au Nord-Kivu (11 595/14 665) et 77,6 % au Haut-Uélé (1 616/2 082).

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Six (6) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours de la journée, dont quatre (4) en Ituri et deux (2) au Nord-Kivu. En Ituri, au PoC Mabakese (ZS de Mambasa), l'alerte d'un voyageur de 19 ans en provenance de Beni a été validée puis le suspect a été transféré au CTE de Mambasa (taux de transfert de 100 %), tandis qu'une seconde alerte au même PoC et celle du PoC Sans Plainte (ZS d'Ariwara) ont été invalidées après le dépistage secondaire ; au PoC Foner Mambasa, le corps sans vie d'un sujet en provenance de l'HGR Mandima a été intercepté et swabé, résultat en attente. Au Nord-Kivu, les deux alertes des PoC Mukulia et Kasitu ont été invalidées après investigation.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 30 septembre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Complétude des rapports	96,7% (58/60)	95,2% (20/21)	100,0% (18/18)	97,0% (96/99)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	143 836	100 400	20 058	264 294
% des voyageurs screenés	97,7%	97,5%	98,9%	97,7%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,4%	97,5%	98,4%	97,5%
% des voyageurs sensibilisés	99,5%	97,5%	100,0%	98,8%
Nombre d'alertes notifiées	4	2	0	6
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	1	0	0	1
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	1	0	0	1
% des cas suspects transférés au CTE/CT	100,0%	NA	NA	100,0%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	100,0%	NA	NA	100,0%
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	NA	NA	100,0%

2.3.Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 43 nouveaux résultats positifs** (32 vivants et 11 décès) sur 209 échantillons reçus et analysés (**positivité : 20,6 %**).
- **Nord-Kivu : 31 nouveaux résultats positifs** (14 vivants et 17 décès) sur 230 échantillons reçus et analysés (**positivité : 13,5 %**).
- **Haut-Uélé : 2 nouveaux résultats positifs** (2 vivants et 0 décès) sur 18 échantillons reçus et analysés (**positivité : 11,1 %**).
- **Tshopo : 10 échantillons reçus et analysés** (10 vivants), tous sont revenus négatifs.
- **Bas Uélé : 7 échantillons reçus et analysés** (5 vivants et 2 décès), tous sont revenus négatifs.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri** : 23 rings ont été ouverts sur 41 (56,1 %), 78 ménages décontaminés sur 80 (97,5 %) et 8 FOSA décontaminées sur 8 (100 %). Sur 76 alertes EDS (dont 5 reports), 54 EDS ont été réalisés (71,1 %) et 55 corps swabés ; 30 écoles ont été dotées en kits PCI à Mongbwalu.
- **Nord-Kivu** : 15 rings ont été ouverts sur 21 (71,4 %), 5 ménages décontaminés sur 27 (18,5 %) et 28 ESS décontaminées sur 30 (93,3 %). Au total, 198 FOSA ont été suivies, 628 prestataires briefés et 33 EDS réalisés, avec 43 corps swabés sur 45 alertes reçues (95,6%).

- **Haut-Uélé** : 2 rings ont été ouverts sur 2 (100 %), 9 ménages décontaminés sur 9 (100 %) et 2 ESS décontaminées sur 2 (100 %). Sur 6 alertes EDS, 5 EDS ont été réalisés (83,3 %) et 5 corps swabés à Isiro et à Wamba ; l'UNICEF a doté la ZS d'Isiro de 2 véhicules et d'un kit de décontamination.
- **Tshopo** : 17 ESS ont été suivies dans 6 ZS et 179 prestataires briefés ; la formation intégrée de 150 PPL des ESS privés se poursuit à Makiso-Kisangani, et le ménage du cas 45, la clinique Vita Nova (cas 44) ainsi que l'HGR Mangobo ont été décontaminés. En cumul, 36 ESS sur 36 (100 %) et 27 ménages sur 31 (87,1 %) ayant accueilli un cas confirmé ont été décontaminés dans les 48 heures.
- **Bas-Uélé** : 9 ESS sur 10 prévues (90,0 %) ont été suivies à Viadana, Buta et Ganga et 38 prestataires briefés (100 %) ; 3 triages sur 4 sont fonctionnels à Buta et les travaux du CTE de Buta se poursuivent. Cinq corps ont été swabés (3 à Ganga, 1 à Buta et 1 à Viadana), sans EDS réalisé.

2.4.2. Défis

En Ituri, l'ouverture des rings demeure insuffisante (56,1 % ; 23/41), d'autres corps n'ont pas été swabés faute d'intrants et d'équipes à Mandima ou à la suite de refus des familles, des résistances persistent à Mangala et à Fataki, et aucun ménage ni ESS décontaminés n'ont été dotés en kits. **À la Tshopo**, l'insuffisance des intrants PCI dans les ESS et la panne de l'incinérateur de l'HGR Makiso-Kisangani persistent. **Au Bas-Uélé**, les CS Bomea et Triangle ne disposent ni de zone à déchets fonctionnelle ni de latrines hygiéniques. **Au Haut-Uélé**, aucun des 9 ménages ni des 2 ESS décontaminés n'ont été dotés en kits.

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 90 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 80 sorties, dont 27 guérisons. Au total, 398 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée. Le taux d'occupation des lits était de **39,2 %** ; 360 patients ont bénéficié de repas chauds et les enfants sous LNPE/SLM ont été intégralement couverts au CTE (13/13), à la crèche (5/5) et dans la communauté (50/50) ; 38 malades sont en état critique.
- **Au Nord-Kivu**, 76 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 71 sorties (7 guéries). Au total, 360 patients demeuraient hospitalisés dont 256 dans les structures normées. Le taux d'occupation des lits était de **72,3 %** ; 20 malades étaient en état critique au CTE de Beni et 127 patients ont bénéficié de repas chauds.
- **À la Tshopo**, aucune nouvelle admission n'a été enregistrée contre 3 sorties rapportées. Quatre (4) patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation de **12,9%**.
- **Au Bas-Uélé**, 10 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 4 sorties au terme de la journée. Onze (11) patients demeuraient en isolement à la fin de la journée.
- **Au Haut-Uélé**, 11 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 18 sorties, dont 5 guérisons. Au total, 69 patients sont en isolement dans les CTE, soit un taux d'occupation de **50,0 %** ; 71 patients, 100 accompagnants et 40 PPL ont bénéficié de repas chauds.

2.5.2. Défis

- **En Ituri**, capacité d'accueil insuffisante de certains CTE/CT et l'insuffisance de la prise en charge alimentaire demeurent préoccupantes.
- **Au Bas-Uélé**, l'absence de CTE normé et d'ambulance pour le transfert des malades demeure un défi opérationnel majeur.
- **À la Tshopo**, la présence continue de cas confirmés en isolement nécessite le maintien des mesures de prévention et contrôle de l'infection.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 86 personnes ont été vaccinées (29 femmes et 57 hommes, dont 1 femme enceinte et 2 femmes allaitantes), sans MAPI notifiée, portant le cumul à 817 personnes vaccinées (348 femmes et 469 hommes). Une rupture temporaire du stock d'ERVEBO a entraîné l'arrêt temporaire des activités de vaccination et de recherche.
- **Au Bas-Uélé**, la vaccination des PPL et TPL s'est poursuivie à Buta, portant le cumul provincial à 1 034 personnes vaccinées sur une cible de 13 202 (7,8 %), principalement à Buta (584 ; 20,4 %) et à Ganga (273 ; 20,5 %). Deux équipes de vaccination compassionnelle sont parties en appui aux ZS d'Aketi et de Viadana.

2.6.2. Défis

En Ituri, la cible des PPL/TPL reste à redéfinir, ce qui empêche le calcul d'un taux de couverture fiable.

Au Bas-Uélé, mise en marche des UCC non effective, pas de disponibilité du micro-plan validé et des fonds de la vaccination.

2.7. Continuité des Soins

2.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, la visite de l'HGR de Bunia a permis de prioriser les activités de son plan de redressement : la séparation physique HGR/CTE et le triage 24h/24 sont effectifs, mais le service d'urgence n'est pas fonctionnel et la fréquentation est en baisse (213 nouveaux cas en juillet 2026 contre 747 en juillet 2025).
- **Au Haut-Uélé**, l'évaluation de l'HS de Nebobongo (ZS de Pawa) révèle une baisse de la fréquentation de plus de 40 % et seulement 43 % de services fonctionnels (rupture majeure) ; le CS Pawa a également été évalué et 2 PPL sont suivis au CTE de Wamba.
- **À la Tshopo**, le Centre médical Horizon a été évalué (2 agents vaccinés sur 11, soit 18,2 %, et zone de triage non effective), le plan de redressement du CM CELPA a été élaboré et la formation des points focaux zonaux sur la continuité des services a démarré.
- **Au Bas-Uélé**, l'évaluation de la ZS de Ganga/Dingila sur la vaccination (mai à août 2026) montre une couverture en Penta 1 comprise entre 84,5 % et 101,7 % et en Penta 2 entre 80,1 % et 93,3 %, pour 95 % attendus, avec un taux d'abandon de 5,2 à 8,9 %

2.7.2. Défis

À la Tshopo, baisse de l'utilisation des services, notamment de la maternité et des césariennes, dans l'ESS évalué ; la fermeture provisoire de l'ESS DHKis reste proposée face à la multiplication des cas confirmés et suspects.

2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 6 900 visites à domicile ont touché 26 866 personnes ; 724 causeries éducatives ont réuni 8 108 personnes, 6 débats communautaires ayant touché 325 personnes et 393 sensibilisations de masse 5 866 personnes, et 81 spots ont été diffusés sur 36 radios. Au total, 170 alertes communautaires, dont 85 décès, ont été notifiées ; 83 feedbacks sur 86 (96,5 %) et les 5 incidents enregistrés ont été résolus dans les 48 heures (complétude de 8 ZS sur 28)
- **Au Nord-Kivu**, 12 509 visites à domicile ont touché 36 982 personnes, 133 causeries éducatives 2 936 personnes et 41 séances de communication de masse 5 424 personnes ; 277 alertes communautaires sur 650 attendues (42,6 %) ont été notifiées et 20 feedbacks sur 25 (80,0 %) résolus dans les 48 heures. La CREC a facilité la réinsertion communautaire de 4 guéris à Vuhovi et à Biena ainsi que la formation de 40 leaders communautaires.
- **À la Tshopo**, 287 visites à domicile ont touché 1 606 personnes, 6 causeries éducatives 251 personnes et 8 séances de sensibilisation de masse 3 018 personnes ; 27 alertes communautaires ont été notifiées (18 à Makiso-Kisangani et 9 à Tshopo) et le feedback reçu a été résolu (1/1), tandis que la sensibilisation des établissements scolaires s'est poursuivie à Mangobo et à Makiso
- **Au Bas-Uélé**, 102 visites à domicile ont touché 1 184 personnes, 6 causeries éducatives 43 personnes et 3 sensibilisations de masse 570 personnes à Viadana, Titule et Ganga ; les 12

alertes communautaires et les 3 feedbacks notifiés ont été traités, et 31 leaders communautaires et religieux ont été sensibilisés dans l'AS de Limba (Viadana).

2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.9.1. Principales actions

- **Nord-Kivu**, 16 cas confirmés sur 17 (94,1 %) enregistrés la veille et 246 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans 6 ZS sur 7 ayant notifié (85,7 %). Les équipes ont pris en charge 112 nouveaux suspects et 406 suspects en cours de suivi, accompagné 24 ménages d'enfants séparés et orphelins sur 34 (70,6 %), annoncé 98 résultats, dont 12 positifs, et réinséré 7 guéris.
- **En Ituri**, 19 cas confirmés sur 32 (59,4%) de la veille, 87 confirmés en cours de suivi sur 126 (69,0 %), 29 nouveaux suspects sur 83 (34,9 %) et 109 suspects en cours de suivi sur 134 (81,3 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 262 accompagnants et 49 PPL, suivi 30 guéris sur 34 en communauté (88,2 %) et annoncé 67 résultats, dont 19 positifs.
- **À la Tshopo**, les équipes ont apporté un soutien psychologique à 2 cas confirmés au CTE Météo, réalisé la psychoéducation de 7 suspects et de 123 personnes, dont 92 élèves à Mangobo, et annoncé 2 résultats négatifs ; 2 guéris ont été suivis en communauté (100 %).
- **Au Haut-Uélé**, 1 nouveau cas confirmé, 20 confirmés en cours de suivi, 7 nouveaux suspects et 5 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS à Isiro, Boma Mangbetu et Wamba ; les équipes ont soutenu 56 accompagnants et 66 PPL, annoncé 7 résultats, dont 3 positifs, et accompagné la sortie de 4 guéris (données de Pawa non transmises).

2.9.2. Défis

- **En Ituri**, 13 ZS affectées sur 28 sont couvertes (46,4 %) ; les psychologues et agents psychosociaux identifiés à Mandima doivent être renforcés en urgence pour les interventions autour des cas.
- **Au Haut-Uélé**, difficultés de mobilité des APS à Wamba et Boma Mangbetu, insuffisance de kits nutritionnels pour les nourrissons sevrés et faible remontée des données à Pawa et Boma Mangbetu.
- **À la Tshopo**, nécessité de former les APS des ZS de Wanie-Rukula et de Bafwasende et insuffisance des moyens de communication et de déplacement du pilier.

2.10. Logistique

2.10.1. Principales actions

- **À la Tshopo**, suivi de l'extension du CTE Météo à une capacité de 30 lits (ajout de 8 chambres) et de la construction du CTE de Bafwasende, finalisation d'un accord d'approvisionnement en carburant à Bafwasende pour l'ambulance (OMS) et appui à la mobilité des piliers.
- **Au Bas-Uélé**, déploiement des équipes de surveillance à Ganga et à Viadana, poursuite de la réhabilitation de la salle de réunion et des bureaux de la DPS (OMS) et de la construction du centre de transit de l'HGR de Buta ; le stock de chlore est limité à 25 kg et le gasoil est en rupture.

2.11. Sécurité

2.11.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, le pilier Mitigation des risques et sécurité a réalisé 6 activités de couverture sécuritaire (100 %), dont l'accompagnement des équipes EDS pour l'enterrement de 2 cas confirmés aux cimetières de Bundji et de Masiani et pour 3 swabs dans la ZS de Katwa, ainsi que de l'équipe PCI pour la décontamination de 3 salles au CM Rwenzori (AS Ngaliika).

2.12. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.12.1. Principales actions

- **En Ituri**, 758 personnes (552 femmes et 206 hommes) ont été sensibilisées sur la PSEA dans la communauté à Bunia, Aru, Rimba et Mongbwalu avec l'appui de l'OMS et de Solidarité ; seules 13 ZS sur 36 (36,1 %) connaissent le mécanisme de signalement.
- **Au Haut-Uélé**, 78 personnes, dont 25 prestataires ayant tous signé le code de bonne conduite, ont été sensibilisées sur la PSEA et le mécanisme de signalement (495555/151) dans l'AS de Mayogo (ZS d'Isiro), notamment les femmes enceintes reçues en CPN au CS VDO.

2.12.2. Défis

Au niveau national, seules 2 DPS ont rapporté leurs activités PSEA (28,6 %) et les CBCM restent peu efficaces.

MESSAGES CLES

- Une transmission communautaire active et soutenue demeure observée dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Haut-Uélé. Tandis que la province du Sud Ubangi n'a notifié aucun cas confirmé au cours des dernières 24 heures et une accalmie est observée dans la province de la Tshopo par rapport aux 72 dernières heures.
- Des progrès à consolider sont enregistrés dans le domaine des investigations épidémiologiques : La quasi-totalité (**95,8 %**) des cas suspects a été investiguée dans les 24 heures suivant leur notification. Toutefois, le taux de suivi des contacts est supérieur par rapport à la veille (**80,6 vs 78,7%**). Cependant, les efforts doivent être fournis afin que ce taux atteigne le seuil requis (95 %).
- Renforcer la surveillance, la prise en charge, la PCI, la logistique et l'engagement communautaire, en privilégiant l'augmentation des capacités des CTE/CT au Nord-Kivu, le transfert rapide des suspects et l'isolement des cas confirmés.
- Renforcer la préparation et la réponse à la MVE-B dans le corridor fluvial et les zones environnantes, notamment au Sud-Ubangi, par la recherche active, le suivi des contacts et la disponibilité des intrants. Poursuivre la surveillance transfrontalière avec le Soudan du Sud.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Dr DIUR MANANASHI Floryan

Mr KAMUINA KEBELA John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd